

# Gestión del Servicio Médico

## Resultados del primer semestre

TANDANOR · Enero-junio de 2026

Informe para Dirección · Actualizado con Planilla Tandanor recibida y confirmaciones de la responsable · 8 de octubre de 2026

|                                                                                |                                                                                 |                                                                             |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>2.542</div> <div>Registros propios</div> <div>Actividad documentada</div> | <div>1.295</div> <div>Registros clínicos</div> <div>Medicina y enfermería</div> | <div>200</div> <div>Vacunas aplicadas</div> <div>Total confirmado</div>     | <div>20</div> <div>Asistentes RCP y DEA</div> <div>Capacitación realizada</div>         |
| <div>38</div> <div>Episodios BP</div> <div>Con presencia en 1S</div>           | <div>28</div> <div>Inicios ART</div> <div>19 AT · 8 AI · 1 EP</div>             | <div>13</div> <div>Rechazos consignados</div> <div>9 AT · 3 AI · 1 EP</div> | <div>35</div> <div>Botiquines revisados*</div> <div>Última fecha registrada en 1S</div> |

### Una gestión que integra asistencia, seguimiento y prevención

El Servicio Médico documentó 2.542 actuaciones propias, además de 80 registros de contratistas. La actividad integra atención médica y de enfermería, gestiones administrativas, seguimiento de BP y ART, vacunación y capacitación en respuesta a emergencias.

La prevención realizada se destaca mediante 200 vacunas aplicadas y una capacitación de RCP y uso de DEA con 20 asistentes, confirmadas por la responsable. El detalle de consultas permite, además, mostrar los grupos clínicos más frecuentes por sector.

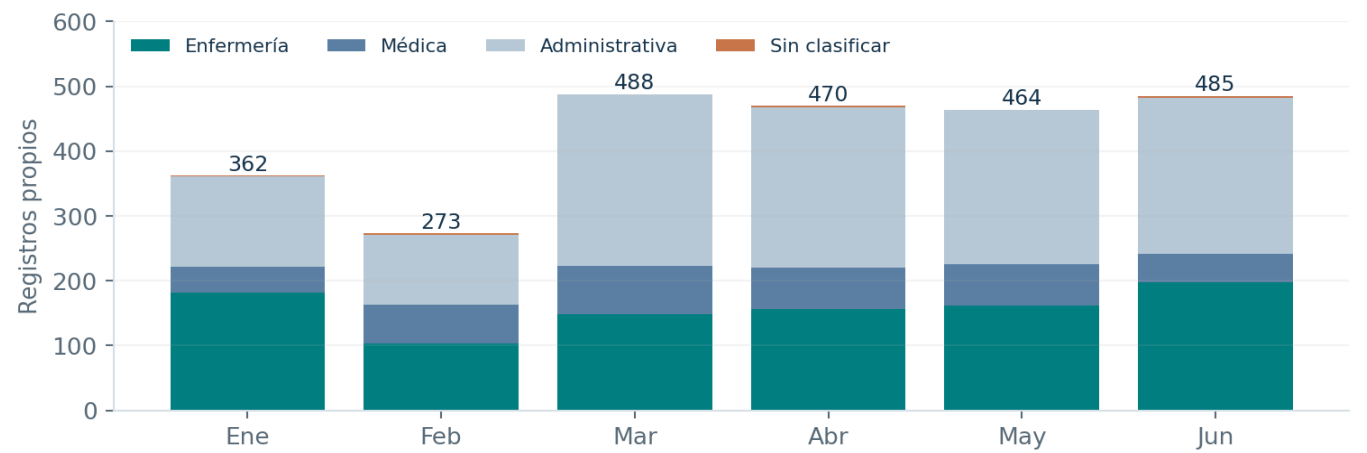
ART: un punto destacado del seguimiento. De los 28 casos iniciados en el semestre, 13 tienen rechazo consignado en la planilla disponible. El informe los separa en AT, AI y EP y distingue la cohorte de inicio de la fecha de decisión.

\*Botiquines: evidencia de última revisión fechada dentro del semestre; no es una tasa de cumplimiento de un programa. Registros, personas, episodios y horas conservan unidades diferentes.

# 1. Actividad y seguimiento realizados

Enero-junio 2026 · Registros por fecha de actuación

La actividad propia comprende 947 registros de enfermería, 348 médicos, 1.238 administrativos y 9 sin clasificación. La clínica suma 1.295 registros.



| Seguimiento administrativo   | BP | ART |
|------------------------------|----|-----|
| Personas con casos presentes | 32 | 30  |
| Arrastre al inicio           | 8  | 4   |
| Inicios en el semestre       | 30 | 28  |
| Altas registradas            | 23 | 26  |
| Activos inferidos al 30/06   | 15 | 6   |

BP registra 23 altas y 15 episodios activos al cierre; ART, 26 altas y 6 activos. El balance hace visible el flujo de seguimiento: arrastre + inicios – altas = activos al corte.

La atención a contratistas suma 80 registros de otra población. Las cantidades consignadas en actividad diaria incluyen 952 comprimidos y 59 inyectables, como detalle parcial de uso; los campos vacíos no equivalen a cero.

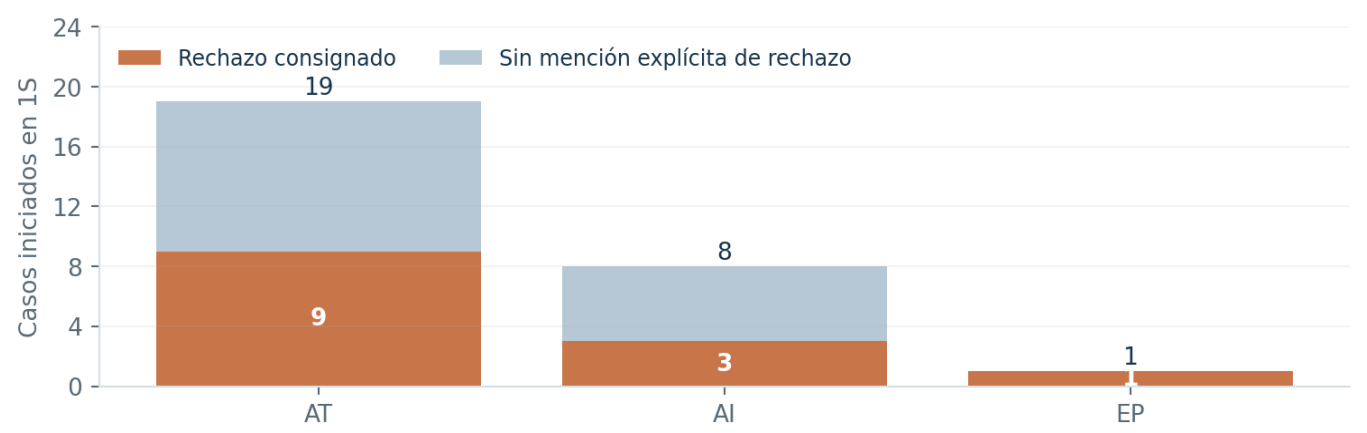
Fuente: Planilla Tandanor.xlsx actualizada · AT. DIARIAS, CONTRATISTAS, BP y ART. Las altas son cierres administrativos registrados, no una medición de éxito terapéutico.

## 2. ART: rechazos por tipo de contingencia

Cohorte: casos con inicio entre el 01/01 y el 30/06/2026 · Estado consignado en la copia disponible

13 de 28 casos iniciados en 1S tienen rechazo consignado. Son 46,4% de esa cohorte documental. Se diferencian los accidentes de trabajo, los accidentes in itinere y las enfermedades profesionales.

| Tipo                        | Casos iniciados 1S | Rechazo consignado | Sin mención explícita de rechazo |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| AT · Trabajo                | 19                 | 9                  | 10                               |
| AI · In itinere             | 8                  | 3                  | 5                                |
| EP · Enfermedad profesional | 1                  | 1                  | 0                                |
| Total                       | 28                 | 13                 | 15                               |



AT concentra 9 de las 13 menciones de rechazo; AI reúne 3 y EP, 1. En EP hay un único inicio observado, por lo que se informa la cantidad y se evita interpretar un porcentaje como patrón estable.

### Cómo leer este resultado

El rechazo consignado, el alta administrativa y el estado del seguimiento son dimensiones diferentes. La ausencia de texto de rechazo no demuestra aceptación. Las observaciones pueden actualizarse después del inicio del caso: esta tabla no atribuye todas las decisiones al primer semestre.

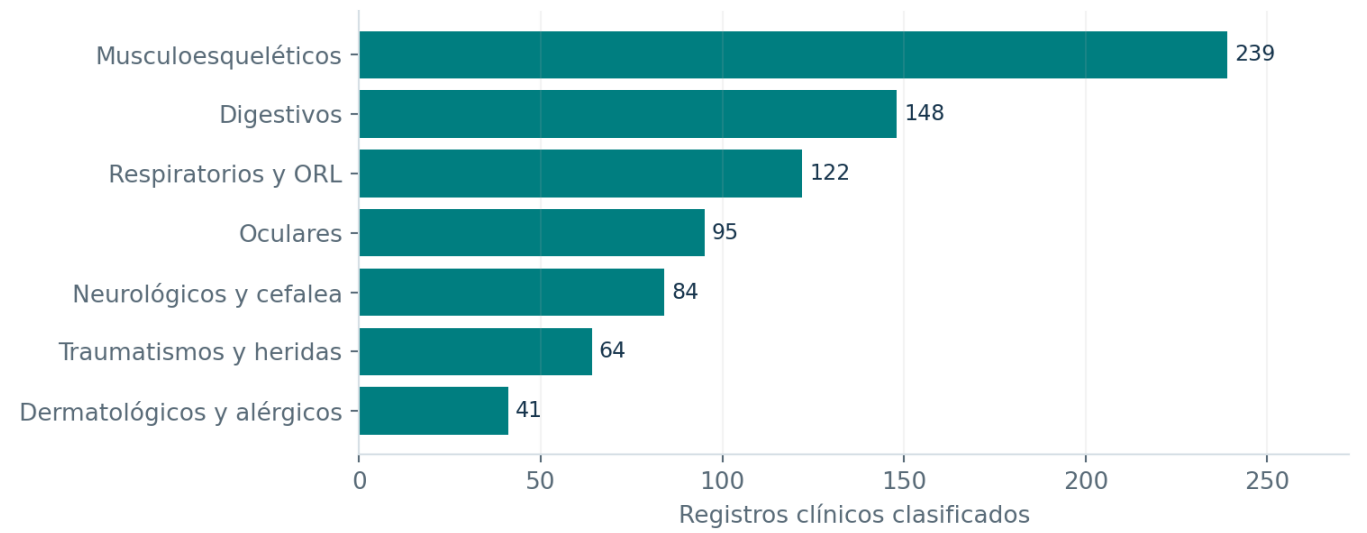
Las fechas textuales de rechazo se conservan en el respaldo agregado según su completitud. No sustituyen una resolución formal; los motivos de decisión no se infieren desde el diagnóstico.

Fuente: Planilla Tandanor.xlsx actualizada · ART. Caso deduplicado por persona, inicio, contingencia y texto diagnóstico. Se presentan agregados AT/AI/EP.

### 3. Grupos clínicos más frecuentes

Patologías y síntomas consignados como motivos de consulta · Medicina y enfermería

De los 1.295 registros clínicos, 832 se clasifican en un grupo clínico único mediante el motivo escrito. El resto incluye prestaciones o controles sin patología, textos no clasificables y motivos de grupos múltiples; se informa separado.



| Grupo clínico              | Registros | % entre clasificados |
|----------------------------|-----------|----------------------|
| Musculoesqueléticos        | 239       | 28,7%                |
| Digestivos                 | 148       | 17,8%                |
| Respiratorios y ORL        | 122       | 14,7%                |
| Oculares                   | 95        | 11,4%                |
| Neurológicos y cefalea     | 84        | 10,1%                |
| Traumatismos y heridas     | 64        | 7,7%                 |
| Dermatológicos y alérgicos | 41        | 4,9%                 |

Musculoesqueléticos, Digestivos y Respiratorios y ORL concentran 61,2% de los registros clasificados. El patrón describe la demanda clínica registrada y permite mostrar qué tipos de atención atiende el servicio.

Una persona puede consultar varias veces. Estos porcentajes no son prevalencia de enfermedad ni certifican un diagnóstico definitivo o su origen laboral. Sólo se desagregan grupos que cumplen el umbral de publicación.

Fuente: Planilla Tandanor.xlsx actualizada · AT. DIARIAS · FECHA, ATENCION y CONSULTA. Clasificación por grupos amplios, sin inferir desde medicación.

## 4. Lectura clínica por sector

Departamento consignado en cada atención · Grupos amplios con protección de celdas pequeñas

| Sector                         | Registros clínicos | Con grupo clínico | Grupos frecuentes mostrados (registros)                                |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Casco Y Acero                  | 267                | 181               | Musculoesqueléticos (58); Oculares (38); Digestivos (25)               |
| Mecanica                       | 144                | 83                | Respiratorios y ORL (20); Digestivos (18);<br>Musculoesqueléticos (16) |
| Carenado                       | 103                | 57                | Musculoesqueléticos (19); Respiratorios y ORL (12);<br>Digestivos (10) |
| Syncrolift                     | 96                 | 70                | Musculoesqueléticos (28); Digestivos (15); Respiratorios y ORL (12)    |
| Servicios Generales            | 81                 | 64                | Musculoesqueléticos (31); Digestivos (9); Traumatismos y heridas (7)   |
| Capital Humano                 | 76                 | 49                | Musculoesqueléticos (16); Respiratorios y ORL (6)                      |
| Electricidad                   | 76                 | 43                | Musculoesqueléticos (13); Respiratorios y ORL (7);<br>Digestivos (7)   |
| Cobreria                       | 60                 | 41                | Digestivos (14); Respiratorios y ORL (7); Neurológicos y cefalea (5)   |
| Bomberos                       | 44                 | 32                | Digestivos (10)                                                        |
| Higiene Y Seguridad Industrial | 42                 | 17                | Digestivos (5)                                                         |

El sector está consignado en 1.260 de los 1.295 registros clínicos. La clasificación se toma del campo DEPARTAMENTO de cada actuación en la copia actualizada.

Las cantidades entre paréntesis corresponden a registros, no a personas enfermas. La tabla ordena solo grupos con al menos cinco registros y cinco personas estimadas; los demás se agrupan y no representan cero. El Excel incluye el detalle agregado y las definiciones.

Fuente: Planilla Tandanor.xlsx actualizada · AT. DIARIAS · DEPARTAMENTO y CONSULTA. No se atribuye causalidad ocupacional a partir de esta distribución.

## 5. Prevención y preparación realizadas

Resultados del primer semestre confirmados y registros fechados

| Acción realizada / registrada | Resultado                                        | Alcance                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vacunación                    | 200 vacunas aplicadas                            | Total informado por la responsable para el semestre.                 |
| Capacitación RCP y uso de DEA | 20 asistentes · 1 actividad realizada            | Realización y concurrencia confirmadas por la responsable.           |
| Revisión de botiquines        | 35 botiquines con última revisión en 1S          | Evidencia de fecha de revisión; no cumplimiento de una periodicidad. |
| Registro de accidentes        | 23 eventos: 15 Tandanor y 8 de otros empleadores | Eventos fechados en 1S; registro distinto de los casos ART.          |

### Vacunación y formación: resultados concretos

La aplicación de 200 vacunas y la capacitación de 20 asistentes en RCP y DEA forman parte de las acciones preventivas realizadas por el servicio durante el primer semestre. Se presentan como resultados confirmados por la responsable.

El padrón de campaña y el detalle parcial de aplicaciones constituyen respaldos que se superponen con el total informado. No se suman al total de 200. Tampoco se convierte automáticamente el número de aplicaciones en personas únicas o cobertura poblacional.

### Recursos y respuesta documentados

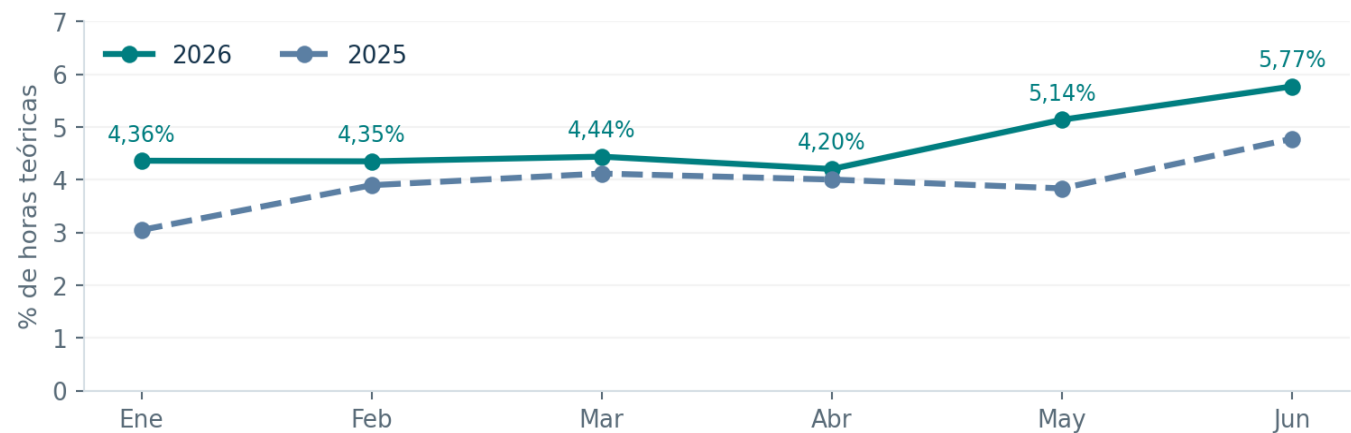
El control de botiquines aporta evidencia fechada de trabajo sobre recursos de emergencia. El registro de accidentes permite mostrar eventos y derivaciones: 15 de los 23 eventos consignan derivación ART. Ambas fuentes describen actividad documentada; sus poblaciones y unidades son diferentes.

Fuente: Confirmaciones de la responsable, 07/10/2026; Copia de Control\_Completo\_Servicio\_Medico\_Astillero2.xlsx · BOTIQUINES, Capacitaciones y Registro Accidentes.

## 6. Ausentismo: contexto y distribución

Primeros semestres comparables de 2025 y 2026 · Horas RRHH conciliadas con los seis índices

El ausentismo médico del semestre es 4,72%: 18.895 horas médicas sobre 400.632 horas teóricas. En 1S2025 fue 3,92%. La variación exacta es 0,795 puntos porcentuales.



| Componente       | 1S2025 (h) | 1S2026 (h) | Diferencia (h) |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Enfermedad       | 13.349     | 14.880     | +1.531         |
| Accidentes / ART | 2.380      | 4.015      | +1.635         |
| Total médico     | 15.729     | 18.895     | +3.166         |

### Concentración de horas por sector

Mecánica, Casco y Acero y Cobreería concentran 53,6% de las horas médicas. El Excel muestra horas y tasas sectoriales. Esta distribución de horas se mantiene separada del ranking de motivos clínicos por sector: son indicadores con numeradores diferentes.

Las tasas semestrales se calculan como cociente de sumas. Los días administrativos BP/ART no se agregan a las horas RRHH. El ausentismo es un resultado organizacional multicausal y no mide por sí solo el desempeño del Servicio Médico.

Fuente: Indicador Ausentismo junio.xlsx; Índice Enero, Febrero, marzo, abril, mayo y junio 2026.xlsx. Comparación médica recalculada desde horas.

## 7. Fuentes y criterios de lectura

Informe de gestión realizada · Corte de producción: 01/01/2026–30/06/2026

| Fuente                                                  | Uso en el informe                                               | Criterio                                                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Planilla Tandanor.xlsx actualizada                      | Actividad, contratistas, BP, ART y motivos clínicos por sector. | Versión sustitutiva: no se suma a la planilla anterior.     |
| RRHH y seis índices mensuales                           | Horas médicas, tasas y distribución sectorial.                  | Conciliación mes a mes; tasa semestral ponderada.           |
| Control Completo Servicio Médico                        | Revisiones de botiquines y accidentes fechados.                 | Se informan actuaciones con evidencia de período.           |
| Confirmaciones de la responsable · 07/10/2026           | 200 vacunas aplicadas y RCP + DEA realizada con 20 asistentes.  | Fuente suplementaria expresa para resultados realizados.    |
| KPI´s Servicio Medico - Tandanor 1er Semestre 2026.xlsx | Modelo de presentación ejecutiva.                               | Se toma su estructura visual; los cálculos se reconstruyen. |

### Unidades que se conservan separadas

Actividad: registros por fecha. BP: episodios administrativos mediante unión de intervalos contiguos o superpuestos por persona. ART: casos deduplicados por persona, inicio, contingencia y texto diagnóstico. Alta: cierre administrativo registrado; activo al corte: inicio vigente y alta ausente o posterior.

Grupos clínicos: patologías o síntomas escritos en CONSULTA; las prestaciones sin patología se separan. Los porcentajes usan registros con un grupo clínico único como denominador. Sector: DEPARTAMENTO de cada atención. Se protegen los grupos pequeños y no se exponen registros individuales.

Rechazos ART: se identifica mención explícita, separando negaciones y ambigüedades. La cohorte se define por fecha de inicio del caso, no por la fecha de resolución. Las fechas expresadas en observaciones se distinguen de la documentación formal.

Se conservaron los 20 documentos originales. La copia actualizada se procesó aparte; el informe y el Excel contienen agregados. Huella SHA-256 de la copia actualizada: d5d2c8abe148ca5c...

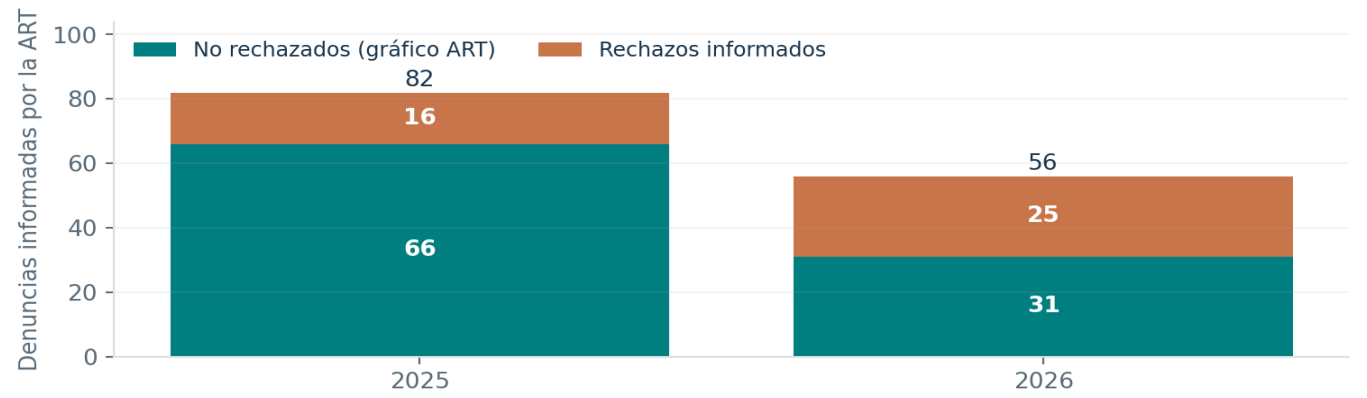
[Abrir el Excel actualizado: resultados, series mensuales, ART y análisis clínico sectorial.](#)

# Anexo A. Siniestralidad enero-septiembre

Provincia ART · Períodos comparables de 2025 y 2026 · Informes originales emitidos el 07/10/2026

Las denuncias informadas por la ART disminuyen de 82 a 56 (−31,7%). El comparativo también muestra más rechazos, casos graves y recaídas. Estos resultados corresponden a enero-septiembre y se presentan como referencia adicional a la gestión del primer semestre.

| Indicador de la ART       | 2025  | 2026  | Cambio       |
|---------------------------|-------|-------|--------------|
| Total de denuncias        | 82    | 56    | −26 (−31,7%) |
| No rechazados del gráfico | 66    | 31    | −35 (−53,0%) |
| Rechazos informados       | 16    | 25    | +9 (+56,3%)  |
| Rechazos / denuncias      | 19,5% | 44,6% | +25,1 p.p.   |
| Días de baja promedio     | 12,72 | 8,73  | −3,99 días   |
| Autodenuncias             | 24    | 27    | +3           |
| Casos graves del gráfico  | 2     | 4     | +2           |
| Recaídas informadas       | 3     | 8     | +5           |



## Distribución de los siniestros no rechazados

En el gráfico de tipos, los casos en el lugar de trabajo pasan de 38 a 16, los in itinere se mantienen en 9, y las enfermedades profesionales pasan de 19 a 6. Son categorías del universo sin rechazos: no representan todas las denuncias por tipo.

La reducción registrada es un resultado favorable de frecuencia. El aumento de la proporción de rechazos interviene en la disminución del universo no rechazado; estas cifras no demuestran por sí solas el efecto causal de la gestión médica.

Fuente: informe-siniestral-202501-202509.pdf e informe-siniestral-202601-202609.pdf · Página 1. El gráfico de gravedad excluye rechazos y COVID.

## Anexo B. Planilla frente al portal de ART

Enero-septiembre de 2026 · Alineación de período con unidades de conteo diferentes

| Recuento de cada fuente                            | Planilla Tandonor | Provincia ART |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Inicios administrativos válidos / denuncias        | 39                | 56            |
| Rechazos consignados / rechazos informados         | 14                | 25            |
| Sin mención de rechazo / no rechazados del gráfico | 25                | 31            |

La planilla usa la fecha BAJA de un caso administrativo; el portal tiene su propio universo de denuncias. Las diferencias de 17 en el total y 11 en rechazos son diferencias agregadas entre fuentes. No identifican por sí solas casos omitidos ni una cobertura del registro.

| Tipo en la planilla | Inicios ene-sep | Rechazo consignado | Sin mención de rechazo |
|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| AT                  | 23              | 9                  | 14                     |
| AI                  | 12              | 3                  | 9                      |
| EP                  | 4               | 2                  | 2                      |
| Total               | 39              | 14                 | 25                     |

Los 14 rechazos consignados se distribuyen en 9 AT, 3 AI y 2 EP. Los PDF originales informan 25 rechazos totales sin desagregarlos por contingencia. Los 25 casos propios sin mención de rechazo no se interpretan automáticamente como aceptados.

### Gráficos, tablas mensuales y recaídas

| Presentación ART                | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|------|------|
| Gráfico: no rechazados          | 66   | 31   |
| Suma de la tabla mensual        | 63   | 23   |
| Diferencia entre presentaciones | 3    | 8    |
| Recaídas informadas             | 3    | 8    |

Las diferencias de 3 y 8 coinciden exactamente con las recaídas informadas. Un tratamiento diferente de las recaídas es una hipótesis consistente con los datos; el informe no explica expresamente ese criterio. Por eso no se presenta la diferencia como un error probado.

Las frecuencias siniestral y judicial utilizan ventanas de 12 meses según el pie del informe. Los días BAJA-ALTA de la planilla y el promedio de días de baja de la ART tienen poblaciones y reglas de cómputo distintas. Para una conciliación caso a caso hace falta el número de siniestro y su estado fechado en ambas fuentes.

Fuente: Planilla Tandonor.xlsx · ART; PDF originales Provincia ART · Páginas 1 y 3. Se excluye un intervalo ALTA anterior a BAJA: 40 filas de inicio 2026 antes de validar fechas, 39 casos válidos.